

URGENCIAS CERVICALES

MASAS CERVICALES

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

INTRODUCCIÓN

Según su causa puede ser dolorosas o indoloras, cuando la causa es indolora los pacientes pueden acudir tarde a solicitar asistencia médica.

Causas de masas cervicales.

Causa infecciosa

- **VIH:** hay adenopatías generalizadas e indoloras, diagnóstico clínico y confirma con serología VIH.
- **Mononucleosis:** malestar general y faringitis, frecuente en adolescentes con múltiples ganglios cervicales, indoloros o moderadamente dolorosos, su diagnóstico se confirma con serología para virus de Epstein-Bar.
- **Infecciones bucofaringeas:** puede ser causa vírica o bacteriana, puede presentarse como una faringitis, infecciones del tracto respiratorio superior o infección dental, se palpa adenopatía aguda dolorosa al tacto de consistencia gomosa, múltiples ganglios linfáticos agrandados, su diagnóstico es clínico con cultivo de fauces.
- **Linfadenitis bacteriana primaria:** presenta una adenopatía aguda con dolor a la palpación.
- **Tuberculosis:** Tiene una adenopatía indolora, formando conglomerados inmóviles, a veces fluctuantes. Su diagnóstico es clínico y se confirma con Mantoux, cultivo y ELISA para tuberculosis.

Causas neoplásicas

- Ganglio local al tumor primario: bucofaríngeo, tiroideo, salival.
- Ganglios distales al tumor primario: linfomas, cánceres de próstata, mamas, colon o riñón, pulmón, digestivos altos.

Causas por trastornos congénitos.

- Quiste del conducto tirogloso.
- Quistes braquiales,
- Quiste dermoides o sebáceos.

Otras causas

- Bocio difuso o nodular
- Tiroiditis subaguda
- Sialoadenitis o cálculos

En pacientes jóvenes las causas más comunes de masa/tumor cervical son:

- **Infección bacteriana primaria del ganglio linfático:** enfermedad por arañazo de gato, la linfadenitis tuberculosa, la toxoplasmosis y las actinomicosis
- **Adenitis reactiva.**
- **Infecciones sistémicas:** mononucleosis, tuberculosis, VIH.
- **Otras causas:** pueden ser los trastornos congénitos y son de larga evolución: quiste del

conducto tirogloso, quistes braquiales, dermoides o sebáceos.

DIAGNÓSTICO

Es clínico.

Características de las masas cervicales

- **Infecciosas:**
 - Inicio agudo
 - Dolor a la palpación, calor, rubor, disminución movilidad cervical
 - Asimétricos. Empastamiento cervical
- **Tumorales:**
 - Inicio insidioso en ocasiones asociado a clínica ORL (disfonía, disnea, disfagia, odinofagia)
 - Duros
 - No dolorosos
 - Fijos a tejidos adyacentes

TRATAMIENTO

Medidas generales si estabilidad hemodinámica.

Dependerá de múltiples factores como del tipo y lugar donde se localice.

Interconsulta con ORL

BIBLIOGRAFÍA

- https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-otorrinolaringol%C3%B3gicos/abordaje-del-paciente-con-s%C3%ADntomas-nasales-y-far%C3%ADngeos/masa-cervical#v946067_es